



جوستاف روسي انترناشيونال - مصر (EPE) * طلب علاج أول مرة / متردد

إسم المريض رباعياً : حنان شعبان حسن عثمان
المحافظة : البحيرة
الحى / المدينة : بدر
رقم البطاقة : 27012152602162 رقم التليفون : 01068264232
العنوان : 0
العمر (تاريخ الميلاد) : 15-12-1970 المهنة : ربه منزل
تاريخ تسجيل الإستمارة : 28-09-2026

الإقرار

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:-التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك
الإخصائي الاجتماعي
التوقيع: (-----)
المقرر بما فيه
التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : علاج مبادرة سرطان الثدي علاج هرموني خط اول تاموكسيفين
قسم العلاج :
الاورام

[14160]

التعليق على التشخيص : -----

تقرير اللجنة الثلاثية المتخصصة

الاسم : د/محمد كيلاني
الاسم : د/ندى حسن
الاسم : د/نرمين رمضان
الوظيفة :
الوظيفة :
الوظيفة :
التوقيع :
التوقيع :
التوقيع :
أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية. كما تقرر اللجنة بأن البيانات المدونة فى هذا النموذج صحيحة.
تعتمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة ومدير
المستشفى.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

أعضاء اللجنة

أ.د. /----- /د. /----- /د. /----- /د. /-----

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :
خطة العلاج :
المستشفى :
قسم :
جهة العلاج :
نفقات :
ملاحظات :

ختم
شعار الجمهورية

مدير عام
مديرية الشؤون الصحية

رئيس
المجلس الطبي المتخصص

--

Name: حنان شعبان حسن عثمان National ID: 27012152602162	
---	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Tamoxifen therapy
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين



٢٠١٩/٠٤

٢٧.١٢١٥٢١.٢١٦٢

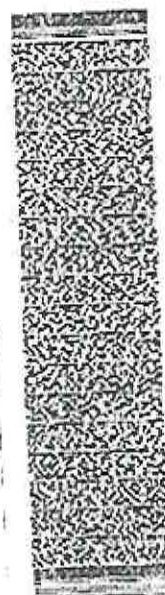
رؤية متوزن

متوزجة

مسلمة

عشرى المراهق حسن

البلقة سارية حق



HY8598805

٢٧٠١٢١٥٢١٠٢١٦٢

حلق
شعبان حسن عطشان
التحريك
مركز بئر - البصرة

مملكة فلسطين الشعبية

MDT FORM 31 / 12 / 2025 G

Name	حنا حبان	MRN	3027 / 2021
Age	55	ID	CV.191057.917
Menopausal status	Hot	Phone	01126777135
NRS SCORE		Marital status	
BMI		Family history	
CO morbidity		REASON OF MDT	AI Shift

Clinical Data

BX: IDC	R	L
ER: 7/8	PR: +	HER 2: +3
Ki67:		

Sonomammography:

2022: Rt breast + Ca

Mets Workup:

ER 7/8, Her2 +3

NACT TCHP → Rt BCS & PCR

adjuvant Hercept 2022

Recommendations:

& No on hormonal th
Tamoxifen Since then "2022

11/2025 → FSH 23, E2 14 "PostMen
for Shift to AI for 35y

MDT OUTCOME & PLAN

f. fenza "complete Zylall"
3-4y + Tamoxifen

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY	Nutrition	Psychiatric

Name: حسان شعبان حسن		
MR. : 5082		
Detailed Medical Report		
		السيد
تحيه طيبة وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
نتشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه The patient has a history of right breast cancer treated with neoadjuvant chemotherapy (NACT) followed by right breast conservation surgery (Rt CBS) with a ypT0N0 pathological result in June 2022. Post-operative management included radiation therapy (PORT) and adjuvant endocrine therapy with tamoxifen. The most recent breast-specific monitoring was a breast-specific mammogram (BSM) performed in September 2025, which was free of disease, and a bone scan conducted in July 2025, also showing no metastatic activity.		
تحريرا في ,		
	التاريخ :	20-09-2026
	الوقت :	
	ندى حسن صلاح كامل	الطبيب المعالج :
يعتمد ,		



Patient Name: Hanan Shaaban Hassan Othman	Date : 06/02/2024
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 53 Year(s)
Medical ID: 327/2021	Pat. ID: 22571

**BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH
RESOLUTION ULTRASOUND**

Indication:

Right breast conserving therapy

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)

Right breast:

- Operative bed parenchymal distortion and scarring with no sizable mass
- No suspicious mass lesions, micro calcifications
- No sizable collection
- Normal skin thickness.
- No regional lymphadenopathy

Left breast:

- No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
- No spiculated mass
- Normal retro-areola ducts
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex
- Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Post right BCS status showing no evidence of recurrence (BIRADS 2)
- Normal study of the left breast (BIRADS 1)

Best regards,
Dr. Eman Abdel Razik, MSc, FEBR
Dr. Amira H Radwan MD,
Breast Imaging consultant,
NCH, Cairo University

Handwritten signature and date: 6/2/2024



Patient Name: Hanan Shaaban Hassan Othman	Date : 03/11/2022
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 52 Year(s)
Medical ID: 3027/2021	Pat. ID: 22571

**BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION
ULTRASOUND**

Indication:

Patient had right CBS in 6/2022

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- The breasts are heterogeneously dense which may obscure small lesions (ACR C)
- right breast UOQ focal area of parenchymal distortion owing to prior surgical interference, with post-operative scarring and diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
- Complementary ultrasound showed right breast UOQ focal parenchyma distortion, owing to prior surgical interference with clear operative bed with no evidence of recurrent mass lesions.
- no left breast solid or cystic mass lesions, normal skin thickness and nipple-areola complex.
- Nonspecific axillary LN, bilaterally with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free right infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Right breast focal parenchymal distortion owing to prior surgical interference (CBS) with post-operative sequel, with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions (BIRADS 2)
- Benign findings of the left breast (BIRADS 1)

Yours truly

Signature Dr. Engy Abdallah

03/11/2022 2:40 PM



Date : 06/02/2024	Patient Name: Hanan Shaaban Hassan Othman
Age : 53 Year(s)	Exam : ultrasound ABDOMEN& PELVIS
	Medical ID: 3027/2021

ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION REVEALED:

Liver: -

- Average in size with homogenous echopattern
- No intra hepatic biliary radicle dilatation or focal lesions.
- Portal vein is patent

Gall Bladder: -

- Average distention with normal wall thickness with no stones.
- CBD is not dilated.

Spleen: -

- Average in size displaying homogenous echopattern, no focal lesions.

Kidneys: -

- Are of normal size , well differentiated & no gross stones or back pressure changes or space occupying lesion could be seen.

Para-aortic and pancreatic area: are concealed by gases.

No ascites or free fluid or collection seen .

Urinary Bladder: -

- Average filling with no stones or focal lesion seen

Opinion:

- Unremarkable study

Best regards
Dr/Shahd M. Fouad ,Msc

PATIENT NAME: HANAN SHABAN HASSAN AOSMAN	PATIENT ID #: 2021159864
GENDER: Female	ORDER #: 1146113,1146119
AGE: 50 y	DATE OF SERVICE: 25-Jul-2021 11:20 AM

Report: - all studies

**MULTI-SLICE POST CONTRAST CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS
WITH TRIPHASIC STUDY OF THE LIVER REVEALED:**

(I) Chest:

- Right breast heterogeneously enhancing mass is seen measuring 2.6 cm.
- Prominent right axillary lymph nodes, the largest measuring 1.9X0.8 cm.
- Patent central air ways with well inflated both lungs.
- Both lung fields are clear showing no parenchymal nodules, cavitary lesions, consolidative patches or bronchiectatic changes.
- No CT evidence of hilar or mediastinal lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collections seen.
- No gross cardiac abnormality.

(II) Abdomen and pelvis:

- The liver is average in size showing homogenous CT density and enhancement with no focal lesions.
- Patent and homogeneously enhancing portal vein.
- No intra or extra hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal CT appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, both kidneys, aorta and IVC.
- Regular filling of the urinary bladder showing no stones, masses or diverticulae.
- Bulky uterus.
- No retro-crural, para-aortic or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.
- Dorsolumbar spondylosis.

OPINION:

- **No CT evidence of metastatic pulmonary or hepatic metastatic disease.**

Reported By,

Dr. Amr Farouk ,MD
Dr. Mahmoud Saleh, MD

25-Jul-2021 02:52 PM



EAJN036749567

مَدَنِي فَائِد

وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مستشفى أورام دار السلام
هرمل ، سابقا
إدارة الجودة

تذكرة العيادة الخارجية

[illegible]

General Examination

Vital signs:

ضغط الدم	درجة الحرارة	النبض	التهنؤن	الوزن
توقيع التمريض				

Marital History: ☐ Married ☐ Single ☐ Widow ☐ Divorced
 Menopausal Status: ☐ Menopausal ☐ Premenopausal ☐ Postmenopausal
 Children: ☐ Yes ☐ No Number:
 Allergy: ☐ Yes ☐ No Comment:
 Adverse drug reaction: ☐ Yes ☐ No Comment:
 Smoking: ☐ Yes ☐ No Comment:
 Pain: ☐ Yes ☐ No Comment:

Complaints: _____

Present History: _____

Past History (hospital admission & surgery):

Family History:



Patient Name: Hanan Shaaban Hassan Othman	Date : 06/02/2024
Exam : MAMMOGRAPHY BOTH	Age : 53 Year(s)
Medical ID: 327/2021	Pat. ID: 22571

**BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH
RESOLUTION ULTRASOUND**

Indication:

Right breast conserving therapy

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- Scattered fibro glandular density (ACR B)

Right breast:

- Operative bed parenchymal distortion and scarring with no sizable mass
- No suspicious mass lesions, micro calcifications
- No sizable collection
- Normal skin thickness.
- No regional lymphadenopathy

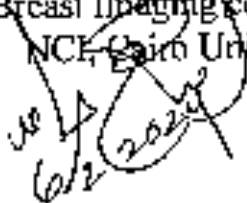
Left breast:

- No suspicious micro calcifications or architectural distortion detected.
- No spiculated mass
- Normal retro-areola ducts
- Normal skin thickness, and nipple-areola complex
- Nonspecific axillary LN.

Opinion:

- Post right BCS status showing no evidence of recurrence (BIRADS 2)
- Normal study of the left breast (BIRADS 1)

Best regards,
Dr. Eman Abdel Razik, MSc, FEBR
Dr. Amira H Radwan MD,
Breast Imaging consultant,
NCE, Cairo University


06/2/2024



Date : 06/02/2024	Patient Name: Hanan Shaaban Hassan Othman
Age : 53 Year(s)	Exam : ultrasound ABDOMEN& PELVIS
	Medical ID: 3027/2021

ABDOMINO-PELVIC ULTRASOUND EXAMINATION REVEALED:

Liver:-

- Average in size with homogenous echopattern
- No intra hepatic biliary radicle dilatation or focal lesions.
- Portal vein is patent

Gall Bladder:-

- Average distention with normal wall thickness with no stones.
- CBD is not dilated.

Spleen:-

- Average in size displaying homogenous echopattern, no focal lesions.

Kidneys:-

- Are of normal size , well differentiated & no gross stones or back pressure changes or space occupying lesion could be seen.

Para-aortic and pancreatic area: are concealed by gases.

No ascites or free fluid or collection seen.

Urinary Bladder:-

- Average filling with no stones or focal lesion seen

Opinion:

- Unremarkable study

Best regards
Dr/Shahd M. Fouad ,Msc

PATIENT NAME: HANAN SHABAN HASSAN AOSMAN	PATIENT ID #: 2021158884
GENDER: Female	ORDER #: 1146113,1146119
AGE: 50 y	DATE OF SERVICE: 25-Jul-2021 11:20 AM

Report: - all studies

**MULTI-SLICE POST CONTRAST CT SCAN OF THE CHEST, ABDOMEN AND PELVIS
WITH TRIPHASIC STUDY OF THE LIVER REVEALED:**

(I) Chest:

- Right breast heterogeneously enhancing mass is seen measuring 2.6 cm
- Prominent right axillary lymph nodes, the largest measuring 1.9X0.8 cm.
- Patent central air ways with well inflated both lungs.
- Both lung fields are clear showing no parenchymal nodules, cavitory lesions, consolidative patches or bronchiectatic changes.
- No CT evidence of hilar or mediastinal lymph node enlargement.
- No pleural or pericardial collections seen.
- No gross cardiac abnormality.

(II) Abdomen and pelvis:

- The liver is average in size showing homogenous CT density and enhancement with no focal lesions.
- Patent and homogeneously enhancing portal vein.
- No intra or extra hepatic biliary radicles dilatation.
- Normal CT appearance of the spleen, pancreas, suprarenal glands, both kidneys, aorta and IVC.
- Regular filling of the urinary bladder showing no stones, masses or diverticulae.
- Bulky uterus.
- No retro-crural, para-aortic or pelvic lymphadenopathy.
- No ascites.
- Dorsolumbar spondylosis.

OPINION:

- No CT evidence of metastatic pulmonary or hepatic metastatic disease.

Reported By,

Dr. Amr Farouk, MD
Dr. Mahmoud Saleh, MD

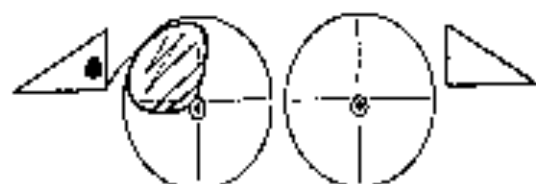
25-Jul-2021 02:52 PM

مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

السلطة المصرية
للحقوق
المرأة

٢٠٢١/٨/٢٤ MDT FORM

Name	حنان تيماني حسن
Age	
MRN	٢٧-١٥١٥٢٦-٩١٦٩
ID	302712021
Co morbidity	١٠١٦٥٠٤٤٠٥٥



Clinical Data

Bx:	SM:
IDC G-II	R+ UOQ multifocal suspicious enhancing mass postmen
IHC:	Mets Workup:
ER: 718	Free
PR: 418	
Hert: 3+	
KITV:	

cT₂ N₁ M₀ cT

COMMENT:

- Bone scan
- Echo, labs
- Clip insertion

MDT OUTCOME & PLAN

- Brain MRI
- Neoadj Chemo AC x4 → Taxol/Hercophor + Perjeta x4 → Consider ACS.B opended cell

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY

14-2-2022

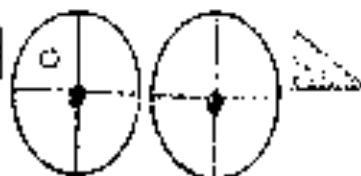


مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

السلطة المصرية
للصحة
محكمة

MDT FORM

Name	هناء محمد
Age	31
MRN	00000000000000000000
ID	00000000000000000000
Co morbidity	C.01 / 2.05



Clinical Data

Bx:	SM:
IHC: ER: 7/8 PR: 6/8 Her2: +++ Ki67:	Mets Workup:
cT3 N1 → yT1 N0 M0	
COMMENT: resect and LAC → 12 who Tumor + 4 x the cystic + Plasmic for CESM to assess R Conservation	

MDT OUTCOME & PLAN

for BCS BCS + SLN (≥ 4mm) After wire localisation

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY



مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

الصحة المصرية
صحة
مصر

MDT FORM

2022/3/2

Name	جاءة محمد	MRN	٢٠٥٧٥٠٥١
Age	54	ID	٥٧٠٤١٥٧٠٥١٢
Menopausal status		Phone	١٢٦٧٧٠٤٤٧٥
OCP		Marital status	
Co morbidity		Family history	

Clinical Data

Rx: TAC 2 II

ER: 7/9 PR: 4/8 HER 2: ++ Ki67:

Sonomammography:

Mets Workup:

Free

CT INI

→ yT.NoM. (PCR)

Recommendations:

Academy of Breastcare post BC+I live

post RACT pathology: → pathological complete response SLNB → o/s pTo pNo

for post operation re MDT

MDT OUTCOME & PLAN

- Adj Trastuzumab SC. x 13 doses
- PORT to Rt. Breast & SC
- Adj hormonal th Arimidex x 54

SIGNATURE

MEDICAL ONCOLOGY

SURGERY

RADIOLOGY

PATHOLOGY



Med. Record No.: 2021158854
Patient Name: HANAN SHABAN HASSAN AQSMAN
Sex: Female DOB: 12/15/1970
Nationality: EGYPTIAN
Unit: External Clinic

SURGICAL PATHOLOGY - Final Anatomical Diagnosis
Biopsy Small - (1 Site)

Specimen Id	2107060250	Sample Type	Tissue
Accession No	SUR21-S040	Requesting Doctor	Abd ALLAH Mohamed Gamil
Collection Date	7/6/2021 12:43:04PM		
Receive Date	7/6/2021 12:43:12PM		

Clinical Information

US guided biopsy from RL breast UOQ suspicious lesion (BIRAD 4C)

Gross Picture

Multiple cores range from 4 up to 8 mm. Totally embedded in one block

Microscopic Picture

A case of invasive duct carcinoma, NST, grade II. There is associated intermediate grade DCIS (solid) pattern, constituting 7% of tumor focus. Stroma shows moderate inflammatory response. Lymphovascular emboli are seen.

Diagnostic Summary

Tumour type:

Invasive carcinoma, NST, grade II.

Laterality

Right

Location

Upper outer quadrant

Specimen type:

Core biopsy.

Histological grade

Mitosis score (1-3):

2

Tubular formation score (1-3):

3

Nuclear grade (1-3):

2

Histological grade (1-3):

2



Med. Record No.: 2021159864
Patient Name: HANAN SHABAN HASSAN AQSMAN
Sex: Female DOB: 12/15/1970
Nationality: EGYPTIAN
Unit: External Clinic

CYTOPATHOLOGY - Final Anatomical Diagnosis
(Cytology - 1 Site) فحص خلوي (1 Site)

Specimen Id: 2107050254 Sample Type: Fluid/ Smear
Accession No: CYTO21-982 Requesting Doctor: Abd ALLAH Mohamed Gamil
Collection Date: 7/6/2021 12:43:07PM
Receive Date: 7/6/2021 12:43:18PM

Nature of Specimen:

LUS guided FNAC from Rt axillary lymph node.

Gross Picture:

Four sections were prepared and Pap stained. One cell block was prepared.

Microscopic Picture:

Cell block and smears show scattered groups of malignant epithelial cells. The groups show glandular differentiation. Pleomorphism is moderate. Picture is of metastatic adenocarcinoma of possible breast origin.

Diagnosis:

Rt axillary lymph node, LUS guided biopsy:
Positive for metastatic adenocarcinoma, consistent with primary breast origin.

Comments:

For clinico-radiologic correlation.

Category Code (LN)

[C8: Malignant]

Signature

[AYA MOHAMMED ISMAIL]

Co-Signed by:

[GHADA MOHAMED MD PHD]

Peritumoural lymphovascular invasion
Absent

Diagnosis

Rt breast UQC mass, US guided biopsy:
Invasive duct. carcinoma, NST, grade 1.

Comments

ER, PR and HER2 were ordered

Biopsy reporting category

BSI= Invasive cancer

Signature

AYA MOHAMMED ISMAIL

Co-signed by:

[GHADA MOHAMED MD PhD.]

completed on: 7/14/2021

Referring Specialty :

Radiology

Type of Request :

Regular

History, Relevant Clinical Findings & Previous Inv. Results:

breast

Previous Pathology Result:

Procedure Done :

Site of Procedure Done:

Side of Procedure Done:

Right

Nature & Number of Specimens:

Reason for Order:

Surgical Pathology Exam

PATIENT NAME: HANAN SHABAN HASSAN AOSMAN	PATIENT ID #: 2021159884
GENDER: Female	ORDER #: 1131295,1131910
AGE: 50 y	DATE OF SERVICE: 08-Jul-2021 09:16 AM

Report: - all studies

CONTRAST ENHANCED SPECTRAL MAMMOGRAPHY AND COMPLEMENTARY ULTRASOUND

INDICATION:

- Right breast suspicious mass lesion (FNAC outside revealed malignant cells).

TECHNIQUE:

- Contrast Enhanced Spectral Mammography CC and MLO view.
- Complementary ultrasound

REPORT:

- Bilateral moderate heterogenous back ground parenchymal enhancement with:
 - Right UOQ intensely enhancing mass lesion measuring 27.6x24mm (index lesion).
 - Another right UOQ two smaller enhancing mass lesions measuring 20x14.5mm and 10x6.5mm, all measuring an area of 92x30mm away from the nipple by 66.5mm (measured on CC view).
 - Right UOQ faint non mass enhancement measuring 41x32mm, collectively with the masses measuring an area of 93x95mm away from the nipple by 66mm.
 - No significant left enhancing lesions.
- Complementary Ultrasound showed right UOQ 9 o'clock three ill defined hypoechoic solid mass lesions measuring 26x25.3mm, 14.5x6.6mm and 8.3x7.6mm respectively, the nearest from the nipple at 25mm.
- Another right 10 o'clock ill defined Isoechoic lesion (corresponding to the non mass enhancement) measuring 22.5x12.2mm.
- Normal skin thickening and breast contour.
- Normal nipple areola complex.
- Right indeterminate axillary lymph nodes.

OPINION:

- Right breast UOQ multifocal suspicious enhancing mass lesions as described (BIRADS 4c) for histopathological correlation.

- No left pathological mass or non mass enhancement (BIRADS1).

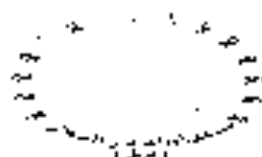
Recommendation - all studies

Referral to clinic

Reported By,

Dr. Mai Magdy, MSc

06-Jul-2021 11:33 AM



Name : Hanan Shaban Hassan

Date : 30-03-2021

MRI EXAMINATION OF THE BRAIN

Technique of examination:

- Axial T1, T2 & Flair WIs "Plate 1-3".
- Sagittal T1 WIs "Plate 4".
- Post contrast axial sagittal and coronal T1 WIs "Plates 5,6,7".

A known case of breast cancer.

MRI Findings:

- Normal size shape & position of the cerebral ventricles with no midline shift or deformity.
- Normal gray–white matter interface with no areas of abnormal signal intensity.
- No evidences of mass lesions.
- No areas of abnormal enhancement are seen at the post contrast scan.
- No gross vascular abnormality.
- Normal cerebellum, brain stem & cervico – medullary junction.
- Normal sellar region.
- Normal extra axial spaces.

Opinion:

- *Normal contrast enhanced MRI study of the brain.*

Dr. Reham Anwar, MSc. FRCR

Dr m.gumaa

Women's Health Outpatient Program

Name: HANAN SHAABAN KASSAB

Date: 17/03/2022

Contrast (enhanced & unenhanced) (fluid & solid) mammography

Clinical Summary

Right breast IDC Grade II

Technique

Pre & post contrast mediolateral oblique and CC views
Targeted High resolution ultrasound

Detailed Findings

Left breast:

- Dense fibroglandular parenchyma. (ACR C)
- Contrast enhanced images demonstrated no mass or non-mass enhancement.
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- No pathological axillary node.

Right breast:

- Dense fibroglandular parenchyma. (ACR C)
- Pre-contrast images revealed the UOQ ill-defined mass in the underlying lesions, located at 9-10 o'clock, largest measuring about 15x7mm.
- Normal skin/nipple/areolar complex.
- No definite pathological axillary lymph node seen.

Conclusion:

- Right breast: Residual UOQ multifocal process, showing no enhancement (BIRADS 6).
- Left breast: normal study (BIRADS 1).

Best regards,

Dr. Mahi Mokhtar

17/03/2022
Tel: 0223555113

17/03/2022
17/03/2022

Name: Hanan Shabaan Hassan

51Y

F

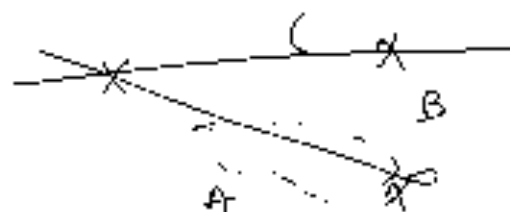
Date: 24/2/2022

Wire localization for right breast masses:

- Under local anesthesia, antiseptic condition and ultrasound guidance.
- Ultrasound guided wire localization was inserted into the right breast 10 o'clock residual.
- With the following distances:
 - Whole distance of the wire till the tip: 3.2 cm
 - Perpendicular distance from skin to tip: 1.2 cm
 - Distance from perpendicular distance to skin entry: 2.9 cm.
- Pre operative breast wire localization.

Marker was placed on the skin over the tip as well as bracketing of the distal extension of the parenchymal distortion.

**Best Regards,
Dr. Ahmed M. Rozeka, MSc**



A = 3.2 cm

B = 1.2 cm

C = 2.9 cm

Dr. Ahmed
 Rozeka
 24/2/2022



Patient Name: Hanan Shaaban Hassan Othman	Date : 03/11/2022
Exam : ultrasound BREAST (BOTH SIDE)	Age : 52 Year(s)
Medical ID: 3927/2021	Pat. ID: 22571

BILATERAL BREAST MAMMOGRAPHY AND HIGH RESOLUTION ULTRASOUND

Indication:

Patient had right CBS in 6/2022

Technique

- Bilateral MLO and CC views
- Bilateral breast ultrasound

Report:

- The breasts are heterogeneously dense which may obscure small lesions (ACR C)
- right breast UOQ focal area of parenchymal distortion owing to prior surgical interference, with post-operative scarring and diffuse edema pattern in the form of increased trabeculations and skin thickness.
- Complementary ultrasound showed right breast UOQ focal parenchyma distortion, owing to prior surgical interference with clear operative bed with no evidence of recurrent mass lesions.
- no left breast solid or cystic mass lesions, normal skin thickness and nipple-areola complex.
- Nonspecific axillary LN, bilaterally with preserved fatty hila and uniform cortical thickness.
- Free right infra and supra clavicular regions.

Opinion:

- Right breast focal parenchymal distortion owing to prior surgical interference (CBS) with post-operative sequel, with free operative bed with no evidence of recurrent mass lesions (BIRADS 2)
- Benign findings of the left breast (BIRADS 1)

Yours truly

Signature Dr. Engy Abdallah

03/11/2022 2:40 PM



٨/١٠

وزارة الصحة
المملكة العربية السعودية
مركز العناية المتخصصة
أمراض القلب

حنا شهاب حسن

اسم المريض ربيعي

رقم الملف الطبي

نوع التوجيه

تاريخ اعداد التوجيه

وقت اعداد التوجيه

ort

EF	61	55-75%	PW1	0.7	0.6-1.1cm
LVEDD	5.3	3.5-5.8cm	AOR	2.9	2-3.7cm
LVEDS	3.5	2-4cm	LA	3.9	2-4cm
FS	33	25-45%	RV	not	0.7-2.3cm(supine)
SWT	0.7	0.6-1.1cm	AO.CUSP	not	1.5-2.6cm

LV dimensions

LV wall thickness

LV diastolic function

SWMA

LA and Ao root dimensions

Mitral Valve

Aortic valve

Tricuspid valve

Pulmonary valve

Right side and systolic function

Intracardiac masses and effusion

Signature MSC

Echo report

Name: *Mohammed Anwar*

Date: 24/8/2021

EF	70	55-75%	PWT	0.8	0.6-1.1cm
LVEDD	5.1	3.5-5.8cm	AOR	3.0	2-3.7cm
LVESD	3.1	2.4cm	LA	3.6	2-4cm
FS	35	25-45%	RV	—	0.7-2.3cm(supine)
SWT	0.9	0.6-1.1cm	AO.CUSP	—	1.5-2.5cm

LV dimensions *normal*

LV wall thickness *normal*

LV diastolic function *GI DD*

SWMA *normal*

LA and Ao root dimensions *normal*

Mitral Valve *thickened & grade II MR*

Aortic valve *normal*

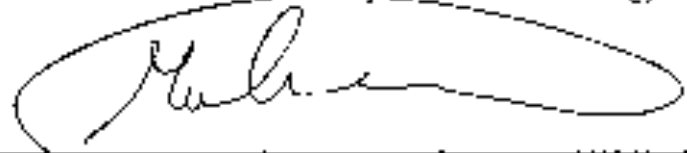
Tricuspid valve *normal & Trivial TR, RV size 19mm*

Pulmonary valve *normal*

Right side and systolic function *normal*

Intracardiac masses and effusion *normal*

Mohammed Anwar, MSc cardiology.



Name	حنان شعبان حسن	Age, Sex	51 Yrs, F
Referred by	Prof. Dr:	Date	23 / 11 / 2021

Transthoracic Echocardiography Report

M- Mode measurements:

	Patient	Normal range		Patient	Normal range
LVED (mm)	52.2	M 42 - 58 F 38 - 52	Ao. Root Annulus(mm)	24	M 23 - 29 F 21 - 25
LVES (mm)	32	M 28 - 40 F 27 - 35	LA (mm)	37.5	M 30 - 40 F 27 - 38
IVS (mm)	9.1	6 - 10	RV Basal diameter(mm)	32	25 - 41
LVPW (mm)	8.7	6 - 11	EF (%)	68	M 52 - 72 F 54 - 74

Comment:

- Normal sinus rhythm, with good echogenicity.
- Normal left ventricular internal dimension with normal wall thickness.
- Good left ventricular systolic function with estimated EF 68 %.
- Normal diastolic function.
- No resting segmental wall motion abnormalities.
- Normal left atrium dimension.
- Normal right ventricle structures and function.
- Mild mitral regurge.
- Normal other cardiac valves morphology and function.
- No pulmonary hypertension.
- No pericardial effusion.
- No apparent intracardiac masses or thrombi.
- Intact interatrial and interventricular septae.

Conclusion:

- Mild MR

Dr. Yaser Gamal
Cardiology specialist

Name	حنان شعبان حسن	Age, Sex	51 Yrs, F
Referred by	Prof. Dr:	Date	22 / 2 /2022

Transthoracic Echocardiography Report

M- Mode measurements:

	Patient	Normal range		Patient	Normal range
LVED (mm)	49.5	M 42 – 58 F 38 – 52	An. Root Annulus(mm)	24	M 23 – 29 F 21 – 25
LVES (mm)	31.4	M 25 – 40 F 22 – 35	LA (mm)	36.8	M 30 – 40 F 27 – 38
IVS (mm)	8.3	6 – 10	RV Basal diameter(mm)	32	25 – 41
LVPW (mm)	8.3	6 – 10	EF (%)	66	M 52 – 72 F 54 – 74

Comment:

- Normal sinus rhythm, with good echogenicity.
- Normal left ventricular internal dimension with normal wall thickness.
- Good left ventricular systolic function with estimated EF 66 %.
- Normal diastolic function.
- No resting segmental wall motion abnormalities.
- Normal left atrium dimension.
- Normal right ventricle structures and function.
- Mild mitral regurge.
- Normal other cardiac valves morphology and function.
- No pulmonary hypertension.
- No pericardial effusion.
- No apparent intracardiac masses or thrombi.
- Intact interatrial and interventricular septae.

Conclusion:

- Mild MR.

Dr. Yaser Gamal
Cardiology specialist

Echo report

Name: *[Signature]*

Date: 2/1/2021

EF	62	55-75%	PWT	0.9	0.6-1.1cm
LVEDD	4.2	3.5-5.8cm	AO R	3.8	2-3.7cm
LVESD	2.7	2-4cm	LA	3.8	2-4cm
FS	33	25-45%	RV		0.7-2.3cm (supine)
SWT	0.9	0.6-1.1cm	AO CUSP		1.5-2.6cm

LV dimensions *Normal*

LV wall thickness *Normal*

LV diastolic function *Normal*

SWMA *Normal*

LA and Ao root dimensions *Normal*

Mitral Valve *Normal*

Aortic valve *Normal*

Tricuspid valve *Normal*

Pulmonary valve *Normal*

Right side and systolic function *Normal*

Intracardiac masses and effusion *No masses or effusion*

[Signature]
[Signature]
[Signature]



Patient Name: *Hanan Shaaban Hassan.*

Date: 14/10/2021

Tc-99m MDP bone scan.

Desired information : skeletal surveying to detect multiple lesions

Technique:

Delayed Anterior and posterior whole body scan 2 hours after I.V administration of 20 mCi ^{99m}Tc-MDP.

Delayed Static Phase:-

- Degenerative changes are noticed over dorsal and lumbar vertebrae for follow up.
- Otherwise the rest of surveyed skeleton is free from serious bone lesions.
- Both kidneys are seen.

Conclusion:

No definite evidence of metastatic osseous deposits.

Follow up bone scan is advised.

Thanks for reference

Nuclear medicine Unit

Huda Fathy , M.D



مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

السلطة الصحية
مصر

MDT FORM

1-78678549

21/3/2022

Name	فايز محمد	MRN	٢٠٩٧٠٩٠٩١
Age	51y	ID	٩٧٠٩٧٠٩٧٠٩٧٠
Menopausal status		Phone	٠١١٧٧٧٧٧٧٧٧
DCP		marital status	
Comorbidity		Family history	

Clinical Data			
Ex:	INC	2	II
EP:	7/1	PR:	4/1
Sonomammography:		HER2:	Ki67:
		+++	
Mets Work up	Pre	CT 3M → yPToNoMo (PCR)	

Recommendations: A case of Rt Breast post BC+ST
post RACT pathology: → pathological complete
response SLNB → 0/5 pT0 pN0
for post-operative re MDT

MDT OUTCOME & PLAN
Pr - Adj Trastuzumab SC. x 13 doses
- PORT to Rt. Breast 2 SC
- Adj hormonal th Arimidex x 54

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY

16 - 2 - 2022

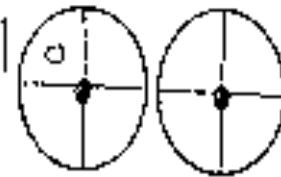


مبادرة رئيس الجمهورية
لدعم صحة المرأة المصرية

الصحة المصرية
شباب
صحة
مصر

MDT FORM

Name	هناء محمد
Age	51
MRN	5.11.151057.5177
ID	1111774440
Co morbidity	C.51 / 4.5V



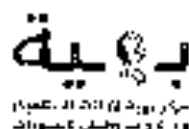
Clinical Data

Bx:	SM:
IHC: ER: 7/8 PR: 4/8 Her2: ++ KITV:	Mets Workup:
cT3 N1 → 4T1 N0 M0	
COMMENT: received LAC → 12 wk Trial + 4 x Herceptin + Plavix for CESM to a MR L Guberstein	

MDT OUTCOME & PLAN

for BCS BCS + SLN (≥ 4 LN) After wire localization
--

SIGNATURE			
MEDICAL ONCOLOGY	SURGERY	RADIOLOGY	PATHOLOGY



Med. Record No.: 2021158854
Patient Name: HANAN SHABAN HASSAN AOSMAN
Sex: Female DOR: 12/15/1973
Nationality: EGYPTIAN
Unit: External Clinic

IMMUNOPATHOLOGY - Final Anatomical Diagnosis

Hormone receptors

Specimen Id 2107100020

Sample Type

Paraffin Block

Accession No IMM21-4204

Requesting Doctor

Abd ALJAF, Mohamed Gamil /

Collection Date 7/10/2021 8:54:08AM

Receive Date 7/10/2021 8:54:13AM

Immunohistochemical Report

pathology number

504023

Clinical Data

RT. breast cancer

Gross Picture :

Referred block submitted for ER/PR immunostaining.

System Used :

Ventana BenchMark ULTRA autostainer

Antibody:

Ventana anti-PR(1E2) Rabbit monoclonal antibody, Ventana anti-ER(SP1) Rabbit monoclonal antibody.

Scoring system :

According to the ASCO/CAP guideline update, 2019 : Samples with 1% to 100% of tumor nuclei positive for ER or progesterone receptor (PgR) are interpreted as positive. If ER (not PgR), 1% to 10% of tumor cell nuclei are immunoreactive, the sample are reported as ER Low Positive. A sample is considered negative for ER or PgR if < 1% or 0% of tumor cell nuclei are immunoreactive. Allied assay: proportion of cells staining (0, no staining; 1, < 1%; 2, between 1% and 10%; 3, between 11% and 33%; 4, between 34% and 66%; and 5, between 67%–100% of the cells staining). Intensity of positive tumor cells (0, none; 1, weak; 2, intermediate; and 3, strong). Total score from 0 to 8
Comment: - There are much more limited data on the 2% to 3% of cancers that are low ER expression (most often defined as 1%-10% ER-positive cells by IHC) and the potential benefit from endocrine therapy. - PR positive in 1-20% of tumor cells is considered as low positive.

(Laterality) breast Cancer:

Right

Diagnosis :

ER: Positive, intermediate nuclear reaction in 70% of tumor cells (7/8)
PR: Low Positive, intermediate nuclear reaction in 5% of tumor cells (4/8).

Signature

GHADA MOHAMED MD PHD.



11/93

وزارة الصحة
وزارة الداخلية
مستشفى الامام

وزارة الصحة والبيئة
امانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز اورام دار السلام

حبيب محمد

م. الطيفي راعي
رقم الملف الطبي
نوع التوجيه
تاريخ اعداد التوجيه
رقم اعداد التوجيه

eport

Date: / / 2021

EF	60	55-75%	PWT	0.9	0.6-1.1cm
LVEDD	5.2	3.5-5.8cm	AO R	3.0	2-3.7cm
LVEDD	3.5	2-4cm	LA	3.7	2-4cm
FS	32	25-45%	RV	normal	0.7-2.3cm(supine)
SWT	1.1	0.6-1.1cm	AO CUSP	normal	1.5-2.6cm

LV dimensions normal

LV wall thickness normal

LV diastolic function normal

SWMA normal

LA and Aortic root dimensions normal

Mitral Valve thickened & trivial MR

Aortic valve normal

Tricuspid valve normal & trivial TR, normal R.V.P.

Pulmonary valve normal

Right side and systolic function normal

Intracardiac masses and effusion normal

D mohammed Anwar

Msc cardiology



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
(هرمل سابقا)
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض :
الرقم الطبي :

الأوامر

Chest:

Temp:

Oral mucositis:

Canula site infection:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

التاريخ: ٢٠٢٠/٢/١٦
الوقت:

توقيع الطبيب : د. / رهنه مصطفى

الأوامر

Chest:

Temp:

Oral mucositis:

Canula site infection:

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

S.m | (P)
B.S

التاريخ: ٢٠٢٠/٢/١٦
الوقت:

التاريخ: ٢٠٢٠/٢/١٦
الوقت:

تاموويت
كالمسيوم
وانا العنا
نور
بابتدول
الاسم
C.C.H

توقيع الطبيب : د. / رهنه مصطفى



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
(هرمل سابقاً)
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض:
الرقم الطبي: ٢٠٢٤/١١/٢٤

الأوامر

Chest:

Temp:

Oral mucositis:

Canula site infection:

2/24 2/24 2/24
1/9/24 2/24 2/24

توقيع الطبيب:
تاريخ: 2/24

Chest:

Temp:

Oral mucositis:

Canula site infection:

24/11/2024

توقيع الطبيب:
تاريخ: 24/11/2024

24/11/2024

توقيع الطبيب:
تاريخ: 24/11/2024

24/11/2024

توقيع الطبيب:
تاريخ: 24/11/2024

24/11/2024

توقيع الطبيب:
تاريخ: 24/11/2024

24/11/2024

توقيع الطبيب:
تاريخ: 24/11/2024

24/11/2024

توقيع الطبيب:
تاريخ: 24/11/2024

24/11/2024

توقيع الطبيب:
تاريخ: 24/11/2024

24/11/2024

توقيع الطبيب:
تاريخ: 24/11/2024

24/11/2024

توقيع الطبيب:
تاريخ: 24/11/2024

24/11/2024



Doctor's Orders أوامر الطبيب

السلامة

6/2/2024 19 r C. L. O. S. M. p. 10 10k
F. r C. L. O. S. M.
r C. L. O. S. M.
q C. L. O. S. M.

توقيع الطبيب :
 ١٥٦٦

الأمم المتحدة

Canula site infection

1. (a) 10/10/10	10/10/10
2. (b) 10/10/10	10/10/10
3. (c) 10/10/10	10/10/10
4. (d) 10/10/10	10/10/10
5. (e) 10/10/10	10/10/10
6. (f) 10/10/10	10/10/10
7. (g) 10/10/10	10/10/10
8. (h) 10/10/10	10/10/10
9. (i) 10/10/10	10/10/10
10. (j) 10/10/10	10/10/10

دار الفکر
الطبعة الأولى: ١٩٨٥
الطبعة الثانية: ١٩٨٥
الطبعة الثالثة: ١٩٨٥



Doctor's Orders **أوامر الطبيب**

الأوامر

توقيع الطبيب : _____

مجلس

وَقَفَّيْجُ الْحَطِيبِ:

العقود
العقود



Doctor's Orders أوامر الطبيب

الأمر

C12 Herceptin 600 mg SC

المؤمنين في الدنيا والآخرة

التاريخ: ٢١ / ٨ / ٢٠٢٢

١٩٩١

[Handwritten signature]

$$F: X \rightarrow X_1 \text{ (ps) } m$$

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. 21. 22. 23. 24. 25. 26. 27. 28. 29. 30. 31. 32. 33. 34. 35. 36. 37. 38. 39. 40. 41. 42. 43. 44. 45. 46. 47. 48. 49. 50. 51. 52. 53. 54. 55. 56. 57. 58. 59. 60. 61. 62. 63. 64. 65. 66. 67. 68. 69. 70. 71. 72. 73. 74. 75. 76. 77. 78. 79. 80. 81. 82. 83. 84. 85. 86. 87. 88. 89. 90. 91. 92. 93. 94. 95. 96. 97. 98. 99. 100. 101. 102. 103. 104. 105. 106. 107. 108. 109. 110. 111. 112. 113. 114. 115. 116. 117. 118. 119. 120. 121. 122. 123. 124. 125. 126. 127. 128. 129. 130. 131. 132. 133. 134. 135. 136. 137. 138. 139. 140. 141. 142. 143. 144. 145. 146. 147. 148. 149. 150. 151. 152. 153. 154. 155. 156. 157. 158. 159. 160. 161. 162. 163. 164. 165. 166. 167. 168. 169. 170. 171. 172. 173. 174. 175. 176. 177. 178. 179. 180. 181. 182. 183. 184. 185. 186. 187. 188. 189. 190. 191. 192. 193. 194. 195. 196. 197. 198. 199. 200. 201. 202. 203. 204. 205. 206. 207. 208. 209. 210. 211. 212. 213. 214. 215. 216. 217. 218. 219. 220. 221. 222. 223. 224. 225. 226. 227. 228. 229. 230. 231. 232. 233. 234. 235. 236. 237. 238. 239. 240. 241. 242. 243. 244. 245. 246. 247. 248. 249. 250. 251. 252. 253. 254. 255. 256. 257. 258. 259. 260. 261. 262. 263. 264. 265. 266. 267. 268. 269. 270. 271. 272. 273. 274. 275. 276. 277. 278. 279. 280. 281. 282. 283. 284. 285. 286. 287. 288. 289. 290. 291. 292. 293. 294. 295. 296. 297. 298. 299. 300. 301. 302. 303. 304. 305. 306. 307. 308. 309. 310. 311. 312. 313. 314. 315. 316. 317. 318. 319. 320. 321. 322. 323. 324. 325. 326. 327. 328. 329. 330. 331. 332. 333. 334. 335. 336. 337. 338. 339. 340. 341. 342. 343. 344. 345. 346. 347. 348. 349. 350. 351. 352. 353. 354. 355. 356. 357. 358. 359. 360. 361. 362. 363. 364. 365. 366. 367. 368. 369. 370. 371. 372. 373. 374. 375. 376. 377. 378. 379. 380. 381. 382. 383. 384. 385. 386. 387. 388. 389. 390. 391. 392. 393. 394. 395. 396. 397. 398. 399. 400. 401. 402. 403. 404. 405. 406. 407. 408. 409. 410. 411. 412. 413. 414. 415. 416. 417. 418. 419. 420. 421. 422. 423. 424. 425. 426. 427. 428. 429. 430. 431. 432. 433. 434. 435. 436. 437. 438. 439. 440. 441. 442. 443. 444. 445. 446. 447. 448. 449. 450. 451. 452. 453. 454. 455. 456. 457. 458. 459. 460. 461. 462. 463. 464. 465. 466. 467. 468. 469. 470. 471. 472. 473. 474. 475. 476. 477. 478. 479. 480. 481. 482. 483. 484. 485. 486. 487. 488. 489. 490. 491. 492. 493. 494. 495. 496. 497. 498. 499. 500. 501. 502. 503. 504. 505. 506. 507. 508. 509. 510. 511. 512. 513. 514. 515. 516. 517. 518. 519. 520. 521. 522. 523. 524. 525. 526. 527. 528. 529. 530. 531. 532. 533. 534. 535. 536. 537. 538. 539. 540. 541. 542. 543. 544. 545. 546. 547. 548. 549. 550. 551. 552. 553. 554. 555. 556. 557. 558. 559. 560. 561. 562. 563. 564. 565. 566. 567. 568. 569. 570. 571. 572. 573. 574. 575. 576. 577. 578. 579. 580. 581. 582. 583. 584. 585. 586. 587. 588. 589. 590. 591. 592. 593. 594. 595. 596. 597. 598. 599. 600. 601. 602. 603. 604. 605. 606. 607. 608. 609. 610. 611. 612. 613. 614. 615. 616. 617. 618. 619. 620. 621. 622. 623. 624. 625. 626. 627. 628. 629. 630. 631. 632. 633. 634. 635. 636. 637. 638. 639. 640. 641. 642. 643. 644. 645. 646. 647. 648. 649. 650. 651. 652. 653. 654. 655. 656. 657. 658. 659. 660. 661. 662. 663. 664. 665. 666. 667. 668. 669. 670. 671. 672. 673. 674. 675. 676. 677. 678. 679. 680. 681. 682. 683. 684. 685. 686. 687. 688. 689. 690. 691. 692. 693. 694. 695. 696. 697. 698. 699. 700. 701. 702. 703. 704. 705. 706. 707. 708. 709. 710. 711. 712. 713. 714. 715. 716. 717. 718. 719. 720. 721. 722. 723. 724. 725. 726. 727. 728. 729. 730. 731. 732. 733. 734. 735. 736. 737. 738. 739. 740. 741. 742. 743. 744. 745. 746. 747. 748. 749. 750. 751. 752. 753. 754. 755. 756. 757. 758. 759. 760. 761. 762. 763. 764. 765. 766. 767. 768. 769. 770. 771. 772. 773. 774. 775. 776. 777. 778. 779. 780. 781. 782. 783. 784. 785. 786. 787. 788. 789. 790. 791. 792. 793. 794. 795. 796. 797. 798. 799. 800. 801. 802. 803. 804. 805. 806. 807. 808. 809. 810. 811. 812. 813. 814. 815. 816. 817. 818. 819. 820. 821. 822. 823. 824. 825. 826. 827. 828. 829. 830. 831. 832. 833. 834. 835. 836. 837. 838. 839. 840. 84

~~XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX~~

القاريخ:
لوقت:

Cyberc
enph
2119.



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
(هرمل سابقاً)
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض :
الرقم الطبي :

الأوامر

Chest:

Temp:

Oral mucositis:

Canula site infection:

Herceptin 600 mg SC
9/24/12
on Ex. Free

CCN, C



C10 Herceptin
cl.ph
2017/2012

د/كريم

توقيع الطبيب :

الأوامر

Chest:

Temp:

Oral mucositis:

Canula site infection:

EF = 61% 10/8/12

C11 Herceptin 600 mg SC

C11 H
aphaga
10/16

التاريخ: 10/1/12
الوقت:

د/كريم

توقيع الطبيب :



Doctor's Orders أوامر الطبيب

الأوامر

Denote:

Oral mucositis: 1/1/96, 2/2

Canula site infection

Herrn

Implications

01-Ph

7/11/2022

التأويل:

الموقف:

١٥٩

Temp:

Oral mucositis:

Canula site infection

[illegible][illegible]

1

1

التاريخ:

الوقت:



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
(هرمل سابقاً)
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض:
الرقم الطبي:

51 سنة

الأوامر

Chest:

Temp:

Oral mucositis:

Canula site infection:

ER 7/8 - PR 4/8

K67

HER +++

Rt Breast Ca

→ P.T. No Mo → PCR achieved

For adjuv: trastuzumab 600 mg sc

X13 doses

توقيع الطبيب:

التاريخ:
الوقت:

أحمد حسين محمد حسن

الأوامر

Chest:

Temp:

Oral mucositis:

Canula site infection:

ophth. B

8/5/4/2022

X1X1
X1X1

سجل
دلتا

5/2/0

توقيع الطبيب:

التاريخ:
الوقت:



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
(هرمل سابقاً)
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض :

الرقم الطبي :

الأوامر

Chest:

Temp:

Oral mucositis:

Canula site infection:

درماتوجراحة

SI 4 e anal absces (chronic)?

for your kind care

1/1/9

التاريخ:

الوقت:

توقيع الطبيب :

الأوامر

Chest:

Temp:

Oral mucositis:

Canula site infection:

patient complains of peripheral neuropathy

R1 Neurovit tab 1x1x3

R1 Gafin 300mg 1x2x3

1/1/9 التاريخ:
الوقت:

توقيع الطبيب :



مركز اخصية المتخصصة
مستشفى اورام دار السلام (هرمس)
الصيدلة الاكلينيكية

TC₄HP (with weekly Paclitaxel) cycle (.....)

| | | | | |
|---|--|---|---------------------------------|--|
| التاريخ: 2022/...../..... | | | | |
| اسم المريض: رقم الملف: | | | | |
| Weight: kg | Height: cm | BSA: M2 | Age: years | |
| CBC: | WBC: | ANC: | Hgb: PLT: | |
| Functions Tests: | Sr.Creat: | Urea: | CrCL: | |
| | ALT: | AST: | T.Bil: D.Bil: | |
| Echo: | Date: | EF: % | | |
| Dose Modification: % | | | | |
| Reason: ☐ Hematological ☐ Non hematological: | | | | |
| امضاء التمريض: | بروتوكول العلاج | | المسرف | |
| الاسبوع الاول: | جرانيسرون (0.01 مجم/كجم) مجم +
ديكساميثازون 20 مجم + لتودين 20 مجم + امبول افيل)
في 50 مل ح 5% على مدى ربع ساعة قبل العلاج
الكماوي.
(Maximum dose of Granisetron = 1mg) | | الاسبوع 1:
بتاريخ 19/11/2022 | |
| الاسبوع الثاني: | بالترياكسيل (80 مجم/2) 1.5.2 مجم في 250 مل ح 5%
على مدى ساعة. | | بتاريخ 19/11/2022 | |
| الاسبوع الثالث: | فازيفولانتين (AUC 3) مجم على مدى ساعة | | الاسبوع 1:
بتاريخ 19/11/2022 | |
| | تراستوزوماب 600 مجم تحت الجلد لمدة 5 دقائق في
الجلد
بروتوزوماب 7.7 مجم في 250 مل ملح على مدى 1/2
ساعة (على مدى ساعة في الجرعة الاولى)
Loading Dose: 840 mg
Maintenance Dose: 420 mg | | بتاريخ 19/11/2022 | |
| كروتولوك قرص 40 مجم على تريق يوميا
ديكساميثازون 8 مجم (امبول او قرص) مرة يوميا اليوم الثاني و الثالث.
☒ جرانيسرون قرص 1 مجم كل 12 ساعة اليوم الثاني و الثالث.
☐ اوندالينز 8 مجم قرص كل 12 ساعة اليوم الثاني و الثالث.
كل ٥ ١ ٣ ٢ ٤ | | بتاريخ 19/11/2022 | | |
| Physician Signature:
فهد سعيد 19/11/2022 | | Clinical pharmacy:
W10 >> Taxol / C ₄ HP 19/11/2022
W11 >> Taxol 28/11/2022
W12 >> Taxol Dose B 2/2
Trastuzumab + pertuzumab >
Date | Dispensing pharmacy:
..... | |

صيدلية
علاء الدين



Ministry OF Health
Dar El-Salam Cancer Hospital
Clinical Pharmacy Team

ph: Aya Fayed
12/11/2021
W7 (taxol)

توفد الجيرة القادمة
بتحاليل جديدة

ADW
12/11/2021
12/11/2021

TCHP (with weekly Taxol) cycle (.....)

التاريخ: 2021 / /
 اليوم:
 اسم المريض:
 رقم الملف:
 Weight: 87 kg Height: 155 cm BSA: 1.9 M2 Age: years
 CBC: WBC: ANC: Hgb: PLT:
 Functions Tests: Sr.Creat: Urea: CrCL:
 ALT: AST: T.Bil: D.Bil:
 Echo: Date: EF: %

Dose Modification: %

Reason: ☐ Hematological ☐ Non hematological:

| امضاء التمريض | بروتوكول العلاج | انصرف |
|-----------------|--|--------------------------------------|
| الاسبوع الاول: | (جر انقريب (D.01 مج/كجم) مج +
نيكسامين 20 مج + ستونين 20 مج + امبول
في 50 مل ج 5% على مدى ربع ساعة قبل العلاج
الكيمائي.
(Maximum dose of Granisetron = 1mg) | الاسبوع 1
بتاريخ 12/11/2021 |
| الاسبوع الثاني: | تفصول (80 مج/2) 15.2 مج في 250 مل ج 5%
على مدى ساعة | الاسبوع 2
بتاريخ 13/11/2021 |
| الاسبوع الثالث: | تفصول (80 مج/2) 15.2 مج في 250 مل ج 5%
على مدى ساعة | الاسبوع 3
بتاريخ 14/11/2021 |
| | هرمستين 600 مج تحت الجلد لمدة 5 دقائق في الفخذ
بريفينا 250 مج في 250 مل منع على مدى 1/2 ساعة
(على مدى ساعة في الجرعة الاولى)
Loading Dose: 840 mg
Maintenance Dose: 420 mg | يعطى بتاريخ
..... / / |

EF 88%
23/11/2021

العلاج التدايمي:
 - كورتزولون قرص 40 مج على طريق يوميا
 - نيكسامين 8 مج (امبول او قرص) مرة يوميا اليوم الثاني والثالث
 - جرانيترون قرص 1 مج كل 12 ساعة اليوم الثاني والثالث
 - اوندانيك 8 مج قرص كل 12 ساعة اليوم الثاني والثالث

Physician Signature:
 Clinical pharmacy:
 Dispensing pharmacy:
 W7: 12/11/2021
 W8: 12/11/2021
 W9: 12/11/2021
 Herceptin + perjeta Date:

12/11/2021



وزارة الصحة والسكان
أمانة المراكز الطبية المتخصصة
مركز أورام دار السلام
(هرمل سابقاً)
إدارة الجودة

Doctor's Orders أوامر الطبيب

اسم المريض :

الرقم الطبي :

الأوامر

Chest:

Temp:

Oral mucositis:

Canula site infection:

Handwritten notes in Arabic, including "Handwritten notes" and "Handwritten notes".

التاريخ:

الوقت:

توقيع الطبيب:

الأوامر

Chest:

Temp:

Oral mucositis:

Canula site infection:

Handwritten notes in Arabic, including "Handwritten notes" and "Handwritten notes".

التاريخ:

الوقت:

توقيع الطبيب:

Handwritten signature and date: 11/05/2020